

Malang, 03 September 2025

Nomor : 1784/E-PTR/DIR/IX/2025
Lampiran : 6 Halaman
Perihal : Surat Konfirmasi

Kepada Yth.
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MALANG
di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama dengan surat ini kami mengajukan konfirmasi tidak dibayarkannya obat berry vision pada beberapa pasien, berikut kami lampirkan juga data pendukung untuk dijadikan pertimbangan (data terlampir)

Konfirmasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Asuransi Center RS Prima Husada Malang : 0813-3142-9720

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

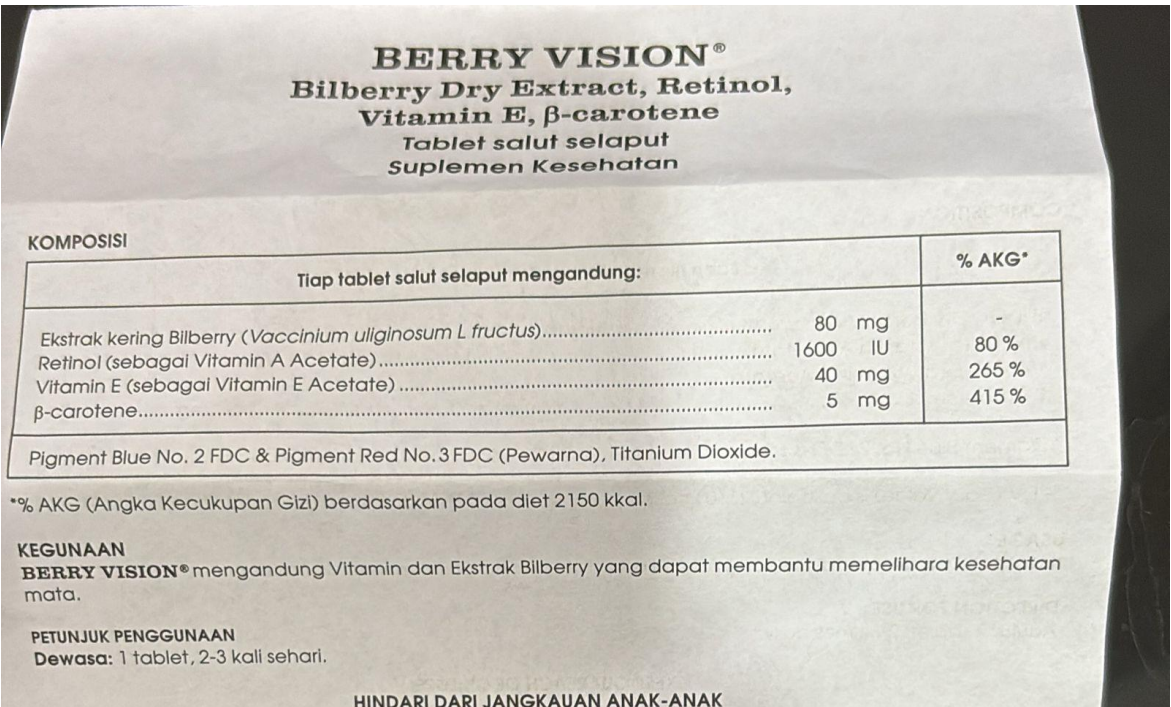
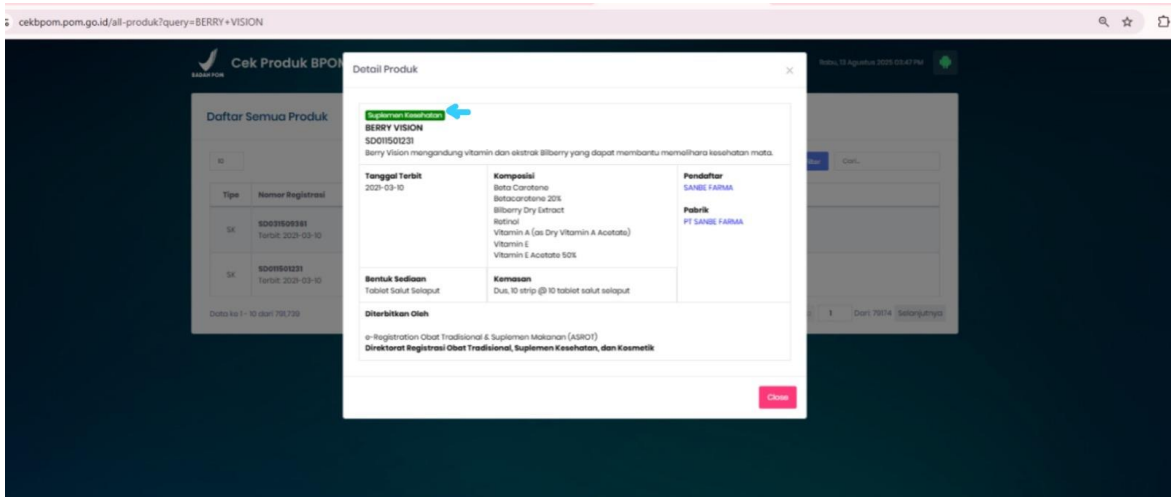
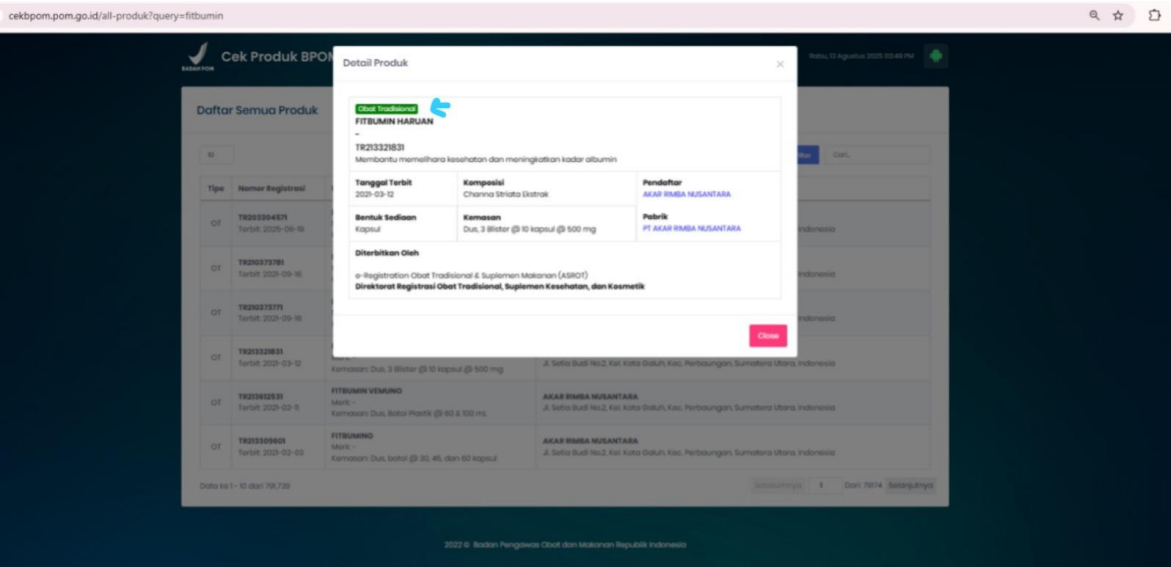


dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN

1. OBAT BPOM

Berry Vision bukan merupakan obat herbal dan sudah memiliki ijin edar obat BPOM dengan beberapa kandungan di dalamnya (terlampir)





2. PKS RS dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pada point IX nomor 4 di jelaskan obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis. Pada kasus yang di naikan klaim berry vision sudah sesuai dengan indikasi medis pasien dengan fungsi meningkatkan sekresi air mata dan antioksidan untuk gejala DED atau syndrome mata kering (sensasi mata perih, rasa terbakar, gatal, adanya lendir berserabut, mata seperti ada benda asing di dalamnya).

IX. HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG

PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. penyakit akibat hubungan kerja (*work related diseases*) yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
2. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
3. Kecelakaan Kerja dan PAK yang diakibatkan dari tindakan yang melanggar hukum;
4. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang tidak sesuai dengan indikasi medis;
5. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;

Halaman 21 dari 63 halaman

European Review for Medical and Pharmacological Sciences

2017; 21: 2518-2525

The effect of a natural, standardized bilberry extract (Mirtoselect®) in dry eye: a randomized, double blinded, placebo-controlled trial

A. RIVA¹, S. TOGNI¹, F. FRANCESCHI¹, S. KAWADA², Y. INABA²,
R. EGGENHOFFNER³, L. GIACOMELLI³

¹Indena SpA, Milan, Italy

²Indena SpA, Tokyo, Japan

³Department of Surgical Sciences and Integrated Diagnostics, School of Medicine, Genoa University, Genoa, Italy

Abstract. – **OBJECTIVE:** Dry eye, a chronic disease of lachrymal fluid and corneo-conjunctival epithelium, could significantly impact visual function, affects quality of life and work productivity. Beside several conventional treatments, nutritional supplements based on bilberry extract have been identified as effective contributors to eye health. Here, we aim at investigating the bioavailability of a standardized bilberry extract, its ability to alleviate dry eye symptoms and its antioxidant potential.

MATERIALS AND METHODS: Either bilberry dried standardized extract derived from *Vaccinium myrtillus* L. fresh frozen fruits (Mirtoselect®) or a highly purified anthocyanin-rich extract, devoid of the non anthocyanin component and supported on maltodextrins, were each orally administered to 5 male rats. Blood samples were collected at 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minutes after treatment, processed and analyzed by UV spectrophotometric method. In a parallel analysis, 22 otherwise healthy subjects suffering from dry eye symptoms were enrolled randomly assigned to receive the more bioavailable bilberry extract or placebo. Ophthalmological and clinical examinations including Schirmer's test, pupil constriction, diacron-reactive oxygen metabolites (d-ROMs) test and biological antioxidant potential (BAP) test were performed at inclusion and after the 4-week study period.

RESULTS: The area under the curve of plas-matic levels of anthocyanosides in rats resulted $202.34 \pm 24.23 \mu\text{g} \cdot \text{min}/\text{ml}$ for Mirtoselect® and $130.93 \pm 4.93 \mu\text{g} \cdot \text{min}/\text{ml}$ for the highly purified anthocyanin-rich bilberry extract, notwithstanding the fact that the highly purified anthocyanin-rich extract group received an anthocyanins dosage much higher than the Mirtoselect® group (354 mg/Kg in anthocyanosides vs. 136 mg/Kg in anthocyanosides). 21 subjects, 11 subjects in the

bilberry extract (Mirtoselect®) group and 10 subjects in the placebo group completed the clinical study. Schirmer's test values indicating the volume of tear secretion were significantly improved in the bilberry extract group ($p=0.019$), whereas no significant changes were observed in the placebo group. A subset analysis revealed that Mirtoselect® could be more effective in subjects with higher tendency of dry eye. In terms of antioxidant potential, the bilberry extract produced significant improvement of BAP ($p=0.003$) and an increase of modified BAP/d-ROMs ratio, an indicator of overall balance between antioxidant potential and oxidative stress.

CONCLUSIONS: Our results suggested that natural, standardized bilberry extract (Mirtoselect®) is a natural more bioavailable delivery form anthocyanins, suggesting a strong matrix effect exerted by the non-anthocyanin component. Furthermore, it can improve tear secretion and plasmatic antioxidant potential in subjects suffering from DED symptoms.

Key Words:

Dry eye, Bilberry extract, Bioavailability, Tear secretion, Antioxidant potential.

Introduction

According to the definition proposed by the International Dry Eye Workshop (DEWS) in 2007, dry eye is "a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symptoms of discomfort, visual disturbance, and tear film instability with potential damage of the ocular surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear film and inflammation of the ocular surface"¹.

2518

Corresponding Author: Luca Giacomelli, Ph.D; e-mail: lu.giacomelli6@gmail.com

3. INDIKASI MEDIS PASIEN



RMRJ 8

UNTUNG RAHARJO

21/05/1969 - 56th 1bln 12hr

232824

CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN RAWAT JALAN

Tanggal	Jam	Catatan	Paraf & Nama Terang
02-07-2025	10:15	S : OD kadang masih terasa pedih , nyeri hilang timbul, pusing O : TD : 120/80 mmHgNadi : 90 x/mntSuhu : 37 °CRR : 22 x/mnt Hiperemi minimal OD vods 6/6 tio ods 17.3//14.4 luka operasi membaik A : Follow up examination after surgery for other conditional Dx. Utama: Follow up examination after surgery for other conditions P : ev inflamasi Rx.: FLAMAR ED 5 ML - SANBE No. I S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal SANBE TEARS TM - SANBE No. I S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal CENDO PROTAGENTA MDS - CENDO No. V S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS No. IV S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral BERRY VISION TAB - SANBE No. V S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral NEUROMED TAB - PROMED No. V S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral	 dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M SIP. 503.2/263.3/KAB/DS/IV/2022

RESUME RAWAT JALAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Nama Pasien : UNTUNG RAHARJO

Tanggal Lahir : 21/05/1969

Usia : 56 Tahun 1 Bulan 12 Hari

No. RM : 232824

Tanggal Berobat : 02/07/2025Jam : 10:15

Anamnesa : OD kadang masih terasa pedih , nyeri hilang timbul, pusing

Pemeriksaan Fisik : TD : 120/80 mmHgNadi : 90 x/mntSuhu : 37,00 °CRR : 22 x/menit

Hiperemi minimal OD
vods 6/6
tio ods 17.3//14.4
luka operasi membaik

Jenis Kasus : ☐ Kasus Baru☒ Kasus Lama

Diagnosa :

Diagnosa

ICD 10

Diagnosa Utama : Follow up examination after surgery for other conditionalZ09.0

Diagnosa Sekunder :

Terapi : BERRY VISION TAB - SANBE No. V
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

CENDO PROTAGENTA MDS - CENDO No. V
S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal

DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS No. IV
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

FLAMAR ED 5 ML - SANBE No. I
S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal

NEUROMED TAB - PROMED No. V
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

SANBE TEARS TM - SANBE No. I
S4dd1 mata kanan,Rute: Topikal

Malang, 02-07-2025
DPJP



(dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M)
SIP. 503.2/263.3/KAB/DS/IV/2022

RMRJ 8

UNTUNG RAHARJO
21/05/1969 - 56th 2bln 9hr
232824

CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN RAWAT JALAN

Tanggal	Jam	Catatan	Paraf & Nama Terang
30-07-2025	10:44	S : px mengatakan OD agak ngganjal, kadang ngeres, sepet, gatal, kabur O : TD : 120/70 mmHg Nadi : 90 x/mnt Suhu : 37 °C RR : 17 x/mnt Hiperemi minimal OD vods 6/6 tio ods 16.7//17.4 luka operasi membaik ff : kesan wnl A : Unspecified disorder of conjunctiva Dx. Utama: Other acute conjunctivitis P : ev tiods Rx.: FLAMAR ED 5 ML - SANBE No. I S3dd1 mata kanan kiri,Rute: Topikal CENDO PROTAGENTA MDS - CENDO No. V S8dd1 gtt mata kanan kiri,Rute: Topikal NEUROMED TAB - PROMED No. X S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral CITICOLINE TAB 500 MG - OGB MAHAKAM No. V S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral BERRY VISION TAB - SANBE No. X S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS No. X S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral	 dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M SIP. 503.2/263.3/KAB/DS/IV/2022

RESUME RAWAT JALAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Nama Pasien : UNTUNG RAHARJO
Tanggal Lahir : 21/05/1969
Usia : 56 Tahun 2 Bulan 9 Hari
No. RM : 232824
Tanggal Berobat : 30/07/2025 Jam : 10:44

Anamnesa : px mengatakan OD agak ngganjal, kadang ngeres, sepet, gatal, kabur

Pemeriksaan Fisik : TD : 120/70 mmHg Nadi : 90 x/menit
Suhu : 37,00 °C RR : 17 x/menit

Hiperemi minimal OD
vods 6/6
tio ods 16.7//17.4
luka operasi membaik
ff : kesan wnl

Jenis Kasus : ☐ Kasus Baru ☒ Kasus Lama

Diagnosa ICD 10
Diagnosa Utama : Unspecified disorder of conjunctiva H10.2
Diagnosa Sekunder :
Terapi : BERRY VISION TAB - SANBE No. X
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

CENDO PROTAGENTA MDS - CENDO No. V
S8dd1 gtt mata kanan kiri,Rute: Topikal, Ket lain: pagi, siang, sore, malam

CITICOLINE TAB 500 MG - OGB MAHAKAM No. V
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

DICLOFENAC SODIUM TAB 50 MG - PHAPROS No. X
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

FLAMAR ED 5 ML - SANBE No. I
S3dd1 mata kanan kiri,Rute: Topikal, Ket lain: pagi, siang, malam

NEUROMED TAB - PROMED No. X
S1dd1 sesudah makan,Rute: Oral, Ket lain: pagi

Malang, 30-07-2025
DPJP

(dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M)
SIP: 503.2/263.3/KAB/DS/IV/2022



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

RM 72

UNTUNG RAHATU

210221001 - 2010 001 2010

232824

Jawa Barat

RINGKASAN PULANG

RAHASIA

Tanggal MRS	19/06/2015	Jam	05.30						
Tanggal KRS	20/06/2015	Jam	12.00						
Riwayat Kesehatan	Nyeri mata kanan part total karena cat silet karena mata merah. gatal. merah.								
Pemeriksaan fisik	Tb lemah Td. 60/40 mmHg N: 86 x/menit P: 36.6 °C RR: 20 x/menit								
Pemeriksaan Diagnostik / Penunjang	DL. Ptt (KPTT). Ur/cr. ECG. Thorax. GPT								
Indikasi dirawat	Magen								
Diagnosa Utama	Obstruksi usus	ICD-10							
Diagnosa Sekunder		ICD-10							
Komorbiditas									
Prosedur (Operatif/Non Operatif) Lain		ICD-9 CM							
Tindakan	Pth Explorasi + Debridement + Enterasi Corpus diena								
Terapi	<table><tr><th>Obat yang diberikan</th><th>Obat setelah keluar RS</th></tr><tr><td>- Tobron 4x1 op - Fluomid 1x1 - Ximol salp 1x1 op - Parasetamol 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1</td><td>- Tobron 4x1 op - Ximol salp 1x1 op - Fluomid 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1</td></tr></table>			Obat yang diberikan	Obat setelah keluar RS	- Tobron 4x1 op - Fluomid 1x1 - Ximol salp 1x1 op - Parasetamol 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1	- Tobron 4x1 op - Ximol salp 1x1 op - Fluomid 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1		
Obat yang diberikan	Obat setelah keluar RS								
- Tobron 4x1 op - Fluomid 1x1 - Ximol salp 1x1 op - Parasetamol 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1	- Tobron 4x1 op - Ximol salp 1x1 op - Fluomid 1x1 - MP 3x16 mg - Cefixime 2x200mg - Analgesik 3x1								
Kondisi Saat Keluar	<table><tr><td>Keadaan Umum:</td><td>☒ Membaik</td><td>☐ Tidak Ada Perbaikan</td></tr><tr><td>Vital Sign</td><td>TD : 86/50 mmHg Nadi : 86 x/menit</td><td>Suhu : 36 °C RR : 20 x/menit</td></tr></table>			Keadaan Umum:	☒ Membaik	☐ Tidak Ada Perbaikan	Vital Sign	TD : 86/50 mmHg Nadi : 86 x/menit	Suhu : 36 °C RR : 20 x/menit
Keadaan Umum:	☒ Membaik	☐ Tidak Ada Perbaikan							
Vital Sign	TD : 86/50 mmHg Nadi : 86 x/menit	Suhu : 36 °C RR : 20 x/menit							
Instruksi Tindak Lanjut	☐ Pulang Atas Permintaan Sendiri ☐ Ekonomi ☐ Jarak RS ☐ Alasan Pribadi ☐ Pengobatan Alternatif ☐ Lain-lain ☒ Pulang Atas Persetujuan ☒ Kontrol tanggal 25/06/15 IGD ☒ Poli Mata Jam: 10.30 DPJP 1: dr. Nurhadi Sp.PP DPJP 2: DPJP 3: ☐ Dirujuk ke : ☐ Operasi, indikasi : ☐ Rujukan Edukasi ke : ☐ PKM ☐ Klinik ☐ Praktik Mandiri ☐ Komunitas ☐ Meninggal, pukul WIB								
Telah dilakukan edukasi tentang seluruh isi dari Form Ringkasan Pulang kepada: ☐ Pasien ☒ Keluarga pasien, nama : Rano ☒ Hubungan dengan pasien : Anak ☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga karena		Nama & Ttd DPJP (dr. Nurhadi, Sp.PP)	Nama & Ttd Pasien/keluarga (Rano dan Rani)						
Lembar 1 : Rekam Medis Lembar 2 : Klaim Lembar 3 : Pasien Lembar 4 : Tenaga Kesehatan		Malang, 20/06/2015 DPJP (dr. Nurhadi, Sp.PP)							



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RM 63

UNTUNG RAHARJO
21/05/1989 - 56th Obin 28hr
232824

Jns. Kol I

LAPORAN OPERASI

Waktu Operasi	Anestesi : pukul 12.30 s/d 13.30 Lama 60 menit Operasi : pukul 12.51 s/d 13.30 Lama 37 menit		
Diagnosis Pra Operasi	ad man dms		
Diagnosis Pasca Operasi	ad pet y ma ok		
Prosedur Operasi	pro explorasi abdomen + ektopik corpus uteri		
Rincian Temuan	corpus alionum		
Jenis Anestesi	Tim Operasi	Pemeriksaan PA	
☒ General Anestesi ☐ RA: ☐ Local Anestesi ☐ Lidocain 2% ☐ Pehacain 2% ☐ Chlorethyl Spray	Operator : Dr. Nuhudi Juh Asisten Operator I : wanda Asisten Operator II : Dokter Anestesi : Dr. H. Juh Asisten Anestesi : Rendhi Instrumentator : Andra Sirkulair/ Onloop : Hendri	Spesimen yang diambil: Pemeriksaan PA ☐ Tidak ☐ Ya Lembar pengantar : sudah/belum*	
Urgensi : ☐ Darurat ☒ Elektif			
Klasifikasi Luka Operasi	Komplikasi	Jumlah darah yang hilang	Jumlah darah yang masuk lewat transfusi
☒ Bersih ☐ Bersih terkontaminasi ☐ Terkontaminasi ☐ Kotor	☒ Tidak ada ☐ Ada:	2 cc	-

Laporan Operasi

- Des infek. lapp yg dengan betadine
- persenput dengan dok man.
- Dehidrasi
- Imunisasi anti tet
- explorasi ditemukan corpus al multiple di lumbus dan corpus uteri.
- ektopik multiple corpus alionum
- Anti biotik faktor
- Saly Anti biotik
- Gawat
- operasi selesai

Malang, 13/06/2021 pukul 13.30 WIB
Dokter Bedah

(Dr. Nuhudi Juh)